

日本岛津

二、实验方法

每柜输液灭菌结束, 关闭进气阀, 渐开排汽阀, 约在 5 min 内表压下降到 0, 等排汽阀中没有余汽排出后稍稍打开柜门, 10 min 后逐渐将柜门完全打开, 再等约 10 min 后将灭菌柜内的三层消毒盘拉至运送车上自然放凉, 次日分别在 a、b、c 三个位置上各取一样一瓶。a 位于灭菌柜柜门开启处的下层角落

附表 吸收度 A 测定结果

编号	葡萄糖注射液	批号	消毒柜号	吸收度 (A)		
				a	b	c
1	5 %	871210 ⁻¹	2	0.0640	0.1330	0.0965
2	10 %	871212 ⁻¹	1	0.0615	0.1235	0.0685
3	10 %	871215 ⁻¹	3	0.0495	0.1100	0.0790
4	5 %	871217 ⁻¹	3	0.1005	0.1605	0.1195
5	10 %	871219 ⁻¹	3	0.0800	0.1320	0.0900
6	10 %	871222 ⁻²	2	0.0770	0.1955	0.1005
7	10 %	871226 ⁻¹	3	0.0995	0.1705	0.1105
8	10 %	880105 ⁻¹	1	0.0630	0.1175	0.0750
9	5 %	880107 ⁻¹	3	0.0760	0.1365	0.0920
10	10 %	880109 ⁻¹	3	0.0570	0.1025	0.0820
11	10 %	880121 ⁻²	2	0.0615	0.1475	0.0755
$\bar{X} \pm SD$				0.0718 $\pm$ 0.017	0.1390 $\pm$ 0.028	0.0899 $\pm$ 0.016

注: 表内输液均为 500 ml 包装。

上, b 位于灭菌柜内的中心位置, c 位于中层消毒盘最后一排的中间位置 (此点也是柜内离进汽口最近的位置)。样品按中国药典 1985 年版规定: 精密量取样品适量 (约相当于葡萄糖 1.0g), 置 100 ml 量瓶中, 加水稀释至刻度, 摇匀, 照分光光度法在 284 nm 的波长处测定吸收度 A。结果见附表。

以上结果经方差分析, a、b、c 三组间差异显著 ($P < 0.05$)。b 组与 a 组差异非常显著 ($P < 0.01$)。b 组与 c 组也有非常显著差异 ($P < 0.01$)。

三、讨论

1. 实验结果说明: 灭菌柜内不同位置上的葡萄糖输液所测得的 5-HMF 紫外吸收度 A 值不同。中心部位的 A 值较其它部位高。

2. 检查 5-HMF 时应在柜的中心部位取样, 所测 5-HMF 之 A 值可反映出本批样本之较高数值; 相反随机取样若所取样品不包含中心部位者, 在所测得的 A 值接近药典规定的限度时, 则本批产品所含之 5-HMF A 值就可能高出规定限度。

医学药物相互作用管理系统软件简介

新疆维吾尔自治区临床药理学研究所

我所电脑室采用增强型 dBAS II plus 数据库语言编制《医学药物相互作用管理系统》软件, 本软件系统限于个人微机系统, 软件运行环境如下:

一、硬件环境

主机: 1 BM—PC/XT 及其他的一切兼容机; 640 内存; 10M 或 20M 硬盘。

打印机: M2024P 型打字机。

驱动器: 5 英寸软盘驱动器二个 (双盘

驱动器一台)。

二、软件环境

系统软件: 西文 DOS 2.0 版本以上; CCDOS 4.0 版本操作系统。

支撑软件: 增强型《dBAS II plus》数据库语言。

三、本软件系统结构设计精巧, 数据库储存有 5500 条医学临床药物相互作用机理资料, 数据资料来源

上海科学技术出版社, 中国药学会上海分会编译:《药物交互作用与禁忌》1980年10月第一版

人民卫生出版社出版, 四川医学院:王文惠主编《药物配合变化》1981年10月第一版

湖南科学技术出版社出版, 贾公孚、谢惠民编.《中西药物相互作用与联合用药》1987年5月第一版

四、用户可以通过以下方式可查询数据

1. 某两种药物或某一类药物配伍查询

- 1) 按药物汉字属名输入查询
- 2) 按药品拉丁文属名输入查询
- 3) 按药物汉字拼音字头输入查询

2. 某药物与其他药物配伍结果查询

3. 某一药物与某一配伍结论查询

五、软件系统的优势

本软件系统检索效果准确性高, 检索速度可在1min之内提供所查询的药物配伍机理, 并将产生的配伍机理和不良反应机制

显示和记录打印, 数据库设计了较完地善编辑和维护功能, 如: 编制了用户自定义数据库, 自定义系统软件密码, 数据库数据自清, 数据库数据输入(键盘输入磁盘输入), 数据的删除、插入、修改, 数据库数据自选备份, 数据库文件的显示和查阅, 库代码的查阅, 以及数据库结构的的修改等功能。为医生和药剂等人员提供可靠准确地用药知识, 同时保证临床治疗用药的合理性, 提高疗效, 达到医疗优质服务的目的。为我国的卫生事业经济体制改革, 提高社会和经济效益, 赶超现代医学技术水平做出贡献。编制软件时, 由于编著条件及水平有限, 不完善或缺点之处, 敬请用户在使用中批评指正, 不胜感激。

需要电话查询有关药物相互作用资料的同志, 请拨区人民医院院内电话: 380

地址: 乌鲁木齐市天池路91号新疆维吾尔自治区临床药物研究所电子计算机室。

全国传染病医院第二届药学研讨会在杭州召开

全国传染病医院第二届药学研讨会于1989年10月18~20日在杭州召开。参加会议的代表来自全国25个省、市、自治区的传染病医院, 正式代表99人, 特邀代表8人, 共107人。

大会由杭州市第六人民医院主办, 中国药学会浙江分会、杭州分会协办。中国药学会北京分会、中国药学会杂志、中国医院药学杂志等均派代表参加了大会。参加本次会议的还有杭州市领导, 浙江医科大学药理学、杭州医学会、杭州市卫生局等领导和专家, 浙江省、杭州市新闻界也出席了大会并作了宣传报道, 大会还收到刚结束的全国首届传染病护理研讨会的贺电。

会议选用论文85篇, 书面交流68篇, 论文内容有: 临床药学、临床药理、药物评价、血药浓度检测、唾药浓度检测、新制剂工艺、药物分析、药房管理、文献综述等, 大会将选用的论文作了论文题录汇编。中国药学会理事北京友谊医院汤光主任、上海医科大学抗生素研究所刘裕昆教授、中国药学会浙江分会顾问於传福、杭州市第六人民医院吴锡铭主任分别在会上做了专题学术报告, 受到与会代表的好评。会议还组织专题研讨: 药剂科科学管理、临床药学、药学专业人员知识更新、社会效益与经济效益关系等。代表们认为药剂科必须强调质量管理, 把社会效益放在首位; 开展临床药学很有必要, 无论医院大小设备好坏, 都可以根据各自情况开展工作。经北京佑安医院等15个理事单位讨论决定: 全国传染病医院第三届药学研讨会定于1991年二季度在北京召开, 由中国人民解放军第302医院主办。主要议题: 消毒药的合理应用、病毒性肝炎的合理用药、药剂科的科学管理、新制剂新技术、新工艺、新成果等。希望尽早组织好专业论文的撰写工作。

(傅志昌 汪友永)